

Módulo 3

El Calostro como Escudo Inmunológico

Intervención de enfermería basada en evidencia para la inmunoprofilaxis en
pacientes neonatales intubados.

Objetivo Central

Establecer la **calostroterapia** como una intervención prioritaria de enfermería para la inmunoprofilaxis neonatal, estandarizando su aplicación clínica.

FUNDAMENTO DEL CALOSTRO

Más que Nutrición

El calostro no debe verse únicamente como un aporte calórico. Es una **intervención inmunológica activa** diseñada para proteger al recién nacido en su estado más vulnerable.

Intervención Temprana

Su administración precoz actúa como la primera "vacuna" mucosa tópica, preparando el sistema de defensa local antes de cualquier colonización por patógenos externos.

COMPONENTES INMUNOLÓGICOS



IgA Secretora

Anticuerpo principal que recubre y neutraliza virus y bacterias directamente en las superficies de las mucosas sin generar inflamación.



Lactoferrina

Proteína fijadora de hierro que impide que los microorganismos patógenos lo utilicen para su multiplicación y crecimiento celular.



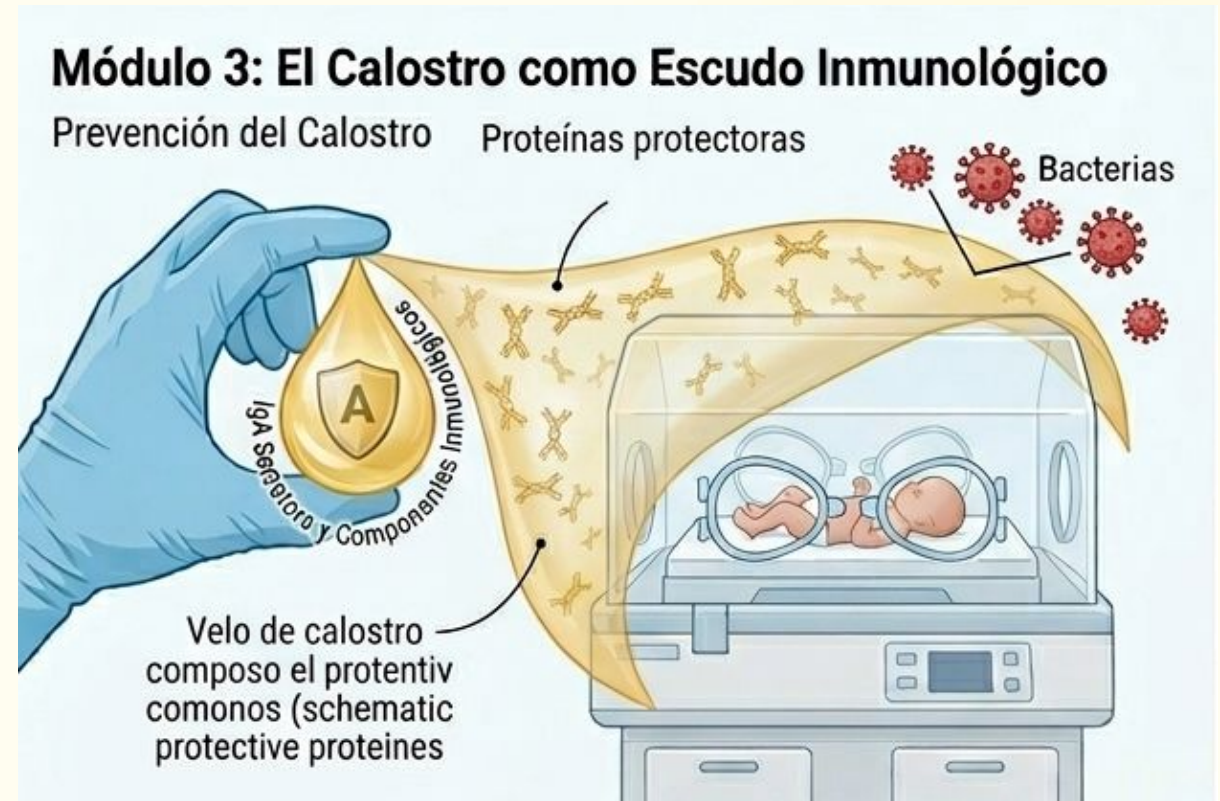
Lisoenzimas

Enzimas naturales que destruyen la pared celular bacteriana, ejerciendo una acción protectora y antibiótica de amplio espectro.

MECANISMO DEL ESCUDO

El calostro forma una **barrera biológica impenetrable** en la mucosa orofaríngea del neonato. Su acción se centra en:

- ✓ Bloqueo inmediato de la adhesión de patógenos.
- ✓ Estimulación del tejido linfoide local (MALT).
- ✓ Prevención del descenso de bacterias a la vía aérea inferior.



| APLICACIÓN CLÍNICA

Terapia Tópica Orofaríngea

Es indispensable comprender que no se trata de alimentación enteral tradicional. El calostro se aplica de manera **tópica** sobre la mucosa bucal.

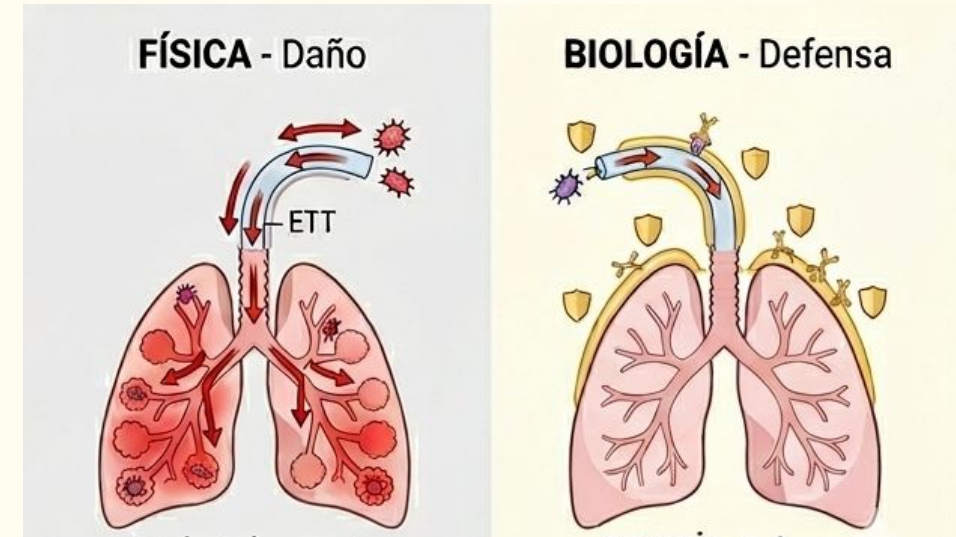
La interacción directa con las células del sistema inmunitario de la faringe desencadena una protección sistémica y local sin comprometer el reposo gástrico del neonato.



RELACIÓN CON LA NAVM

NAVM

Neumonía Asociada a Ventilación



El Contrapeso Biológico

El tubo endotraqueal actúa como una vía de invasión directa que anula el filtrado fisiológico buconasal. El calostro es el contrapeso inmunológico directo que compensa el riesgo mecánico de la intubación.

| FÍSICA VS. BIOLOGÍA

- ✓ **El Daño Físico:** La intubación endotraqueal rompe las defensas glóticas, propiciando la microaspiración constante de secreciones contaminadas.
- ✓ **La Defensa Biológica:** La calostroterapia impregna la cavidad bucal, taponando los receptores celulares donde los patógenos intentarían proliferar.
- ✓ **Sinergismo Profiláctico:** Disminuye drásticamente la carga bacteriana bucal antes de que ocurra cualquier arrastre mecánico a los pulmones.

PROYECTO DE MAESTRÍA HGZ

Diagnóstico

Evaluación de las tasas actuales de NAVM y prácticas de enfermería en el hospital.

Estandarización

Desarrollo formal del protocolo clínico para la calostroterapia en la UCIN.

Capacitación

Entrenamiento técnico de enfermería en la técnica estricta de aplicación oral.

Seguridad

Monitoreo constante del cumplimiento de metas de seguridad del paciente neonatal.

PROTOCOLO CLÍNICO

Parámetro	Especificación Técnica de Enfermería	Frecuencia
Volumen	0.2 ml distribuidos en cada mejilla interna (total de 0.4 ml por sesión)	Cada 3 a 4 horas (sincronizado con el reloj de enfermería)
Procedimiento	Frotar suavemente con un hisopo o jeringa estéril la mucosa yugal y las encías	Inmediatamente después de la higiene bucal reglamentaria
Insumo	Calostro fresco de la propia madre (idealmente extraído al pie de cama)	Durante las primeras 48 a 72 horas del nacimiento

Por una Práctica de Enfermería Científica

La calostroterapia representa la evolución de un cuidado asistencial ordinario hacia un modelo de excelencia e inmunoprotección avanzada en el HGZ.

¡Su labor es la primera línea de defensa de nuestros neonatos!